研究定位与可用范围

研究性质

单中心回顾性研究， 23 例（ 23 眼），病例来自 2020 年 1 月至 2025 年 6 月；没有随机分组或对照组。

2026 刊 p122–123 / PDF1–2

入选条件

中央或旁中央病灶；裂隙灯及前节 OCT 示浸润深度≤ 1/2 角膜厚度；全身及局部抗真菌治疗 3~7 d 未见明显好转。

2026 刊 p123 / PDF2

排除条件

非真菌性角膜感染、全层穿孔、眼内炎、出血 / 凝血疾病，以及高血压、糖尿病等严重基础病控制不佳者被排除。

2026 刊 p123 / PDF2

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

病原与术前评估

真菌性角膜溃疡：病损切除联合伏立康唑 · 2026 单篇回顾性病例系列

病原诊断

真菌培养、角膜涂片镜检或共焦激光显微镜任一项发现真菌菌丝或孢子，纳入真菌性角膜溃疡病例。

2026 刊 p123 / PDF2

研究前检查

裂隙灯、前节 OCT 评估位置和浸润深度，病原学及共焦检查；最大浸润直径 4~7 mm 为本样本描述，不是手术切点。

2026 刊 p122–123 / PDF1–2

研究局限

样本小、随访较短、无对照；不能证明优于药物或移植，也不能据此推广至深层浸润、穿孔或眼内炎患者。

2026 刊 p123 、 125 / PDF2 、 4

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

研究用药：术前方案

真菌性角膜溃疡：病损切除联合伏立康唑 · 2026 单篇回顾性病例系列

术前全身用药

本文方案：氟康唑注射液 0.2 g 静滴，一天一次。属于研究治疗记录，不是普适处方推荐。

2026 刊 p123 / PDF2

术前局部用药

5% 那他霉素滴眼液每小时 1 次； 10 g/L 氟康唑滴眼液每小时 1 次；小牛血去蛋白提取物眼用凝胶睡前一次。

2026 刊 p123 / PDF2

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

研究手术方案与缺项

病损切除范围

标记直径略大于溃疡边缘 0.5 mm；切除深度不超过角膜基质层厚度 1/2，以透明无浸润为准；修剪范围超过边缘 0.5 mm。

2026 刊 p123 / PDF2

基质注射记录

原文记录 10 g/L 伏立康唑注射液， 30G 针，多点基质内缓慢推注，留针 10 秒，覆盖病变区域。单点体积、总量、配制细节：原文未明确。

2026 刊 p123 / PDF2

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

术后监测与再次浸润

术后治疗

术后用药同术前，局部频次降至每日 4~6 次；每日裂隙灯观察上皮愈合和再浸润。再浸润者采用结膜下注射伏立康唑，剂量原文未明确。

2026 刊 p123 / PDF2

随访项目

出院后复查最佳矫正视力、共焦激光显微镜与角膜愈合情况；统一复诊间隔、停药标准、特殊人群剂量：原文未明确。

2026 刊 p123 / PDF2

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

结果、时间与证据局限

主要结果

21 例（91.3%）病情有效控制，溃疡愈合时间 5~17 d； 2 例（8.7%）再浸润，追加处理后减轻。所有病例随诊最终愈合，未因感染加重移植。

2026 刊 p123 / PDF2

恢复与不良事件

平均治疗周期约 90 d； 1 例（4.3%）并发性白内障， 2 例（8.7%）远视漂移。 5~17 d 的溃疡愈合不能替代约 90 d 整体治疗周期。

2026 刊 p123 / PDF2

原文数据核对项

正文部分例数 / 百分比及表 1 例数存在不一致；保留主结果 23 例的表述，不自行修正分母。 10 g/L 注射浓度为原文记录，不能据此补造注射体积。

2026 刊 p123–125 / PDF2–4

一页流程｜真菌性角膜溃疡：病损切除联合伏立康唑

研究解读路径 · 不等同指南推荐 · 2026

1 病原确认

培养 / 涂片 / 共焦任一见菌丝或孢子 → 核对研究入选条件。

2026 刊 p123

2 是否符合研究范围?

中央 / 旁中央且浸润≤ 1/2 角膜厚度? 否 → 不适用本文路径；是 → 核对排除条件。

2026 刊 p123

3 初始抗真菌治疗

按本文术前方案记录治疗； 3~7 d 无明显好转 → 研究中进入手术评估。

2026 刊 p123

4 研究手术方案

病损切除联合多点基质伏立康唑；总注射体积原文未明确，不补造。

2026 刊 p123

5 术后是否再浸润?

每日裂隙灯；再浸润 → 原文追加结膜下注射（剂量未明确）；无 → 继续观察愈合。

2026 刊 p123

6 随访与研究边界

复查视力 / 共焦 / 愈合；统一停药与复诊阈值未明确。此为研究路径，不是指南推荐。

2026 刊 p123 、 125

流程为整理表达；原文未明确的切点、剂量或等级不补编。完整证据与特殊分支见提取表。